

# Séminaire gynécologique & mammari

Ménarchée = âge 1<sup>er</sup> règles spontanée (de 11 ans à 16)

GXPX → Pointe nt naissance récente

G1P0: fausse couche

G1P2: jumeaux

mètre dans centre santé sexuelle PAS CEGGID

↳ Gestité: nt total grossesse

Durée du cycle:

- Sporadioménorrhée (+35 jours), cycle long
- Cycle normal (28j)
- Polychiménorrhées (-21 jours), cycle court

1/3 grossesses non prévues → 6/10 abortif en IVG

1/3 avortif non contrôlé

Bille TOP1

↳ Stéril

35 ans

30 ans

45 ans: 19% sans contraception

Douleurs:

- Dysménorrhée = règles douloureuses (uniquement pendant la menstruation)
- Dyspareunies = douleurs rapports sexuels (superficielles/profondes)

Indice de Pearl = efficacité théorique

Caractéristiques des règles:

- Aménorrhée primaire = n'a jamais eu ses règles
- Aménorrhée secondaire = plus de règles depuis ≥ 3 mois
- Durée des règles:

→ Hypoménorrhée: règle courte < 3 jours

→ Hyperménorrhée: règle longue > 8 jours

Abondance:

→ Oligoménorrhée: peu abondante

→ Polyménorrhée: trop abondante

→ Ménorragie: règles trop longues et trop abondantes

→ Métrorragie: saignements qui surviennent en dehors des règles

Risque Thrombo-embolique

Insuline résistance; ↑ Cholestérol HDL; ↑ TG

↑ Tension; Risque K surin

Mais protège K cardiovasc/ coronar

Risque Androgénique (cancer testicules) + Métrorragie/saignement

Gestive (éthylalactate)

Progestatif (lévonorgestrel)

1. Anti gonadotrope  
↓  
LH/FSH  
↓  
ovulation

2. Antiprolifératif endomètre  
atrophique MMS spotting

3. Epaisit glaire cervical

Ménométrorragie = { ménorragie + métrorragie }

→ règles trop longues, trop abondantes et point de saing Anovulation

Leucorrhée = desquamation vagin

↳ Oligo: blanches & irritées

↳ Polib: abondantes

Inspection mammaire

↳ Mastodynie?

↳ écoulement? ... pur

↳ galactorrhée? ... lait

Examen mammaire

↳ Pos/taill/IMC

↳ Palpation + ganglions axillaires

Adhérence mammaire: normal avec p grand pectoral?

↳ marqueurs d'adhérence → longue lésion adhésive p

qui: dans le mal

→ pas → que le sein

Contre-indications oestro-progestatif: Maladie Thrombo-embolique (AVC; infarctus)

Normes de point

Régulation

• X I.R.C: insuff. rénale chronique (altérée)

• Post-partum immédiat non! (risque embolie + ↓ lactation)

• Migraines avec aura = contre-ind. absolue!

↓  
≤ 50 ans - C est ok!

Suivi endométrial & dysfonction

# Contraception

1<sup>re</sup> it = COP (contraceptif oestrogénique) + DIU cuivre + DIU levonorgestrel  
 ↳ 2<sup>ème</sup> it = progestatif seul

COP: 3 semaines + 1 placebo (12h tolérer)

Progestatif = 28 jours en continu! (mieux 12h → oestradiol 12h)

⚠ Toujours doses βHCG avant la pose d'un implant

## Contraception d'urgence

| Hormonale     | Non Hormonale   |
|---------------|-----------------|
| Norlevo (72h) | DIU cuivre (5j) |
| Ellone (5j)   | Levonorgestrel  |

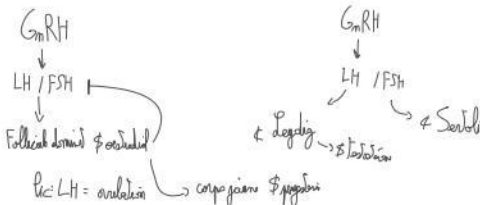
Pas efficace à 100% → βHCG à 15 jours

Sterilisation → délai obligatoire 4 mois réflexion

**Infertilité**  
 ↳ Primaires = jamais enfant  
 ↳ Secondaires = 1 ou 2 a déjà eu des enfants

1/3 HT  
 1/3 F  
 1/3 en couple, marié

↳ Examen: à 12 mois tentatives (ou 6 mois si > 35 ans)  
 si couple de femme ou femme seule  
 si puberté hormonale pour évaluer l'endométriose



## Aménorrhée lactatérale (méthode MAMA)

Progestatif → pilule / DIU / implant  
 COP → pilule / patch / anneau

DIU = Typ 1 mais 2<sup>ème</sup> en France

Levonorgestrel

Mirena / Kyleena

Pb: ménorragie

CI:

même que progestatif (controle...)

Cuivre (seul non hormonal)

≈ 5 ans

effets toxiques sur gamètes (sans implant)

Pb:

↑ Abondance & durée des règles

Aménorrhée ferropénique

CI:

Eclampsie sévère / infection

Maladies de Wilson (surcharge en cuivre)

Saignements utériniques

Préservatif: indice Pearl 0,8 à 22% en pratique !!!

↳ Mais seul latex IST

Dosage AMH (réservé ovarien)

↳ échographie pelvienne = morphologie normale

↳ occam des trompes → Hystérocopie: échographie avec cathéter  
 1<sup>re</sup> it en - double

Hystérosalpingographie

radio + contraste sous 32<sup>ème</sup> it + double